جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : غاده راضى عبدالحفيظ عباس

المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** اوسيم **العنوان :** 2ش حنان صبحي ش سعد زغلول مركز اوسيم- الجيزه

رقم البطاقة : 28202061801321 **رقم التليفون :** 01271502775 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 15-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 06-02-1982 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي المقر بما فيه

التوقيع:(----------) **التوقيع:(----------)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج كيماوي تاكسان (دوسيتاكل) [14152] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------

خطة العلاج : ----------

المستشفي : ----------**قسم :** ----------

جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------

ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: غاده راضي عبدالحفيظ عباس
National ID: 28202061801321

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Docetaxel chemotherapy**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



غاده
راضى عبدالحفيظ عباس
٢ش حنان صبحى ش سعد زغلول
مركز أوسيم - الجيزه

٢٨٢٠٢٠٦١٨٠١٣٢١

JM0978917

٢٨٢٠٢٠٦١٨٠١٣٢١ ٢٠٢٢/٠٧
حاصله على بكالوريوس تجاره

أنثى مسلمة متزوجة
عماد حمدى عوض محمد
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٧/٢٦

١

١٠٧١٥٠٠٢٧٧٥

١٠٠٨٤٧٠٠٢٩٢

عينه ٧/١

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

NHTMRI

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

قسم الباثولوجى

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: غاده راضي عبدالحفيظ
Request type: مبادره
Hospital no:
Department: صحه مراه
Referred by: د/مروه حسن
Nature of specimen: tru-cut biopsy
Clinical diagnosis: Right breast mass

Age: 44years
Sex: female
Sub request type:
Pathology no.:568B-2026
Date of result:11/7/2026
Date of biopsy:1/7/2026
I.D. Number:28202061801321

Gross pathology :

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 0.5x0.4cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against Ecadherine- ER- PR- Her2- KI67

Microscopic picture: Section examined revealed cores of breast tissue showing mixed invasive duct carcinoma of no special type (NST) and invasive lobular carcinoma. The tumor forms sheets, clusters, trabeculae and tubules of anaplastic ductal cells infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showed moderate anaplasia and moderate tendency to from tubules. There are foci showing mildly pleomorphic poorly cohesive cells arranged in files.

Immunohistochemical Result

Ecadherine: Diffuse positive in tumor cells
ER: Moderate nuclear staining in 70% of tumor cells (Allred Score 7/8).
PR: Moderate nuclear staining in 30% of tumor cells (Allred Score 5/8).
Her2: Strong complete membranous staining of >10% of tumor cells (score 3+) positive.
Ki67: Positive nuclear staining of 60% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass, tru-cut biopsy:

Invasive duct carcinoma (NST), Grade II.

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient ID: 96724	Patient Name English: Gada Rady Abdalhafiz
Age: ٤٤ سنة, ٣ شهر	2026/06/28 12:45:28 PM :Report Date

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 44 years old female patient with right breast lump.

Detailed Findings

Right breast:

- Dense fibro glandular parenchyma (ACR density d).
- The right breast shows posterior 1/3 ill-defined irregular dense mass lesion with obscured margins (more appreciated at tomosynthesis)
- **Ultrasound** revealed ill defined heterogenous mass lesion measures about 29x24 mm away from nipple by 6 cm and skin 5mm Associated overlying skin thickening, there is multiple retro areolar dilated ducts reaching to 5mm surrounding by un healthy parenchyma seen extending from nipple to lesion between 8-9 o'clock
- Normal nipple/areolar complex.
- One enlarged axillary lymph nodes at level I measuring 27x18mm
- No infra or supraclavicular lymph nodes,

Left breast:

- Dense fibro glandular parenchyma (ACR density d).
- No asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Multiple small dispersed subcentimetric thin-walled anechoic cysts.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Right breast (BIRADS 5)**: Right LIQ malignant mass lesion with ipsilateral pathological axillary For tru cut biopsy and CESM study.
- **Left breast (BIRADS 2):** left breast fibrocystic changes.

Much obliged,

Dr. Marwa M.Hassan

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: غاده راضي عبدالحفيظ
Request type: مبادره
Hospital no:
Department: صحه مرأه
Referred by: د/مروه حسن
Nature of specimen: tru-cut biopsy
Clinical diagnosis: Right breast mass

Age: 44years
Sex: female
Sub request type:
Pathology no.: 568B-2026
Date of result: 11/7/2026
Date of biopsy: 1/7/2026
I.D. Number: 28202061801321

Gross pathology :

Multiple fragmented grayish white tissue cores up to 0.5x0.4cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against Ecadherine- ER- PR- Her2- KI67

Microscopic picture: Section examined revealed cores of breast tissue showing mixed invasive duct carcinoma of no special type (NST) and invasive lobular carcinoma. The tumor forms sheets, clusters, trabeculae and tubules of anaplastic ductal cells infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showed moderate anaplasia and moderate tendency to from tubules. There are foci showing mildly pleomorphic poorly cohesive cells arranged in files.

Immunohistochemical Result

Ecadherine: Diffuse positive in tumor cells
ER: Moderate nuclear staining in 70% of tumor cells (Allred Score 7/8).
PR: Moderate nuclear staining in 30% of tumor cells (Allred Score 5/8).
Her2: Strong complete membranous staining of >10% of tumor cells (score 3+) positive.
Ki67: Positive nuclear staining of 60% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass, tru-cut biopsy:

Invasive duct carcinoma (NST), Grade II.

Signature:
Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

Pathology Report [[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]